

Uso de Insulina en el Embarazo: Una Guía para Mujeres Embarazadas

¿Por qué Insulina?

Durante el embarazo, es crucial mantener niveles de azúcar en la sangre bien controlados para garantizar un embarazo saludable y un bebé sano. Aunque la metformina se usa en algunos casos, la insulina es el tratamiento preferido cuando la glucosa no se controla adecuadamente solo con dieta y cambios en el estilo de vida. La insulina no atraviesa la placenta y es la opción más segura y eficaz. Se usará insulina durante el resto del embarazo y se podrá suspender después del parto cuando los niveles de azúcar en sangre se normalicen.

Tipos de Insulina

Insulina de acción prolongada (insulina basal): Proporciona un control estable del azúcar en sangre durante el día y la noche. Ejemplos incluyen insulina detemir (Levemir) e insulina glargina (Lantus, Toujeo, Basaglar, Rezvoglar). Se administra una vez al día por la noche y debe tomarse aproximadamente a la misma hora todos los días, por ejemplo, entre las 6:00 y 8:00 p.m. Esta insulina dura hasta 24 horas.

Insulina de acción rápida (insulina en bolo): Actúa rápidamente para reducir el azúcar en sangre después de las comidas. Ejemplos incluyen insulina lispro (Humalog, Lyumjev), insulina aspart (Novolog, Fiasp) e insulina glulisina (Apidra). Se administra 5-10 minutos antes de las comidas. La comida debe estar lista antes de inyectar la insulina. Esta insulina dura aproximadamente 3-4 horas.

Cómo Administrar la Insulina

Elección del Sitio de Inyección

Áreas recomendadas: Abdomen (al menos a 5 cm del ombligo), muslos externos, parte posterior de los brazos superiores o parte superior de los glúteos.

Rotar los sitios de inyección para evitar la formación de bultos o acumulación de grasa (lipohipertrofia).

Preparación para la Inyección

- Lávese las manos con agua y jabón.
- Retire la tapa de la pluma de insulina y coloque una aguja nueva. Cebe la pluma girando dos unidades y presionando el botón de dosis hasta que salga insulina por la punta de la aguja.

Técnica de Inyección

- Pellizque la piel si usa una aguja corta; no es necesario pellizcar con una aguja más larga.
- Inserte la aguja en un ángulo de 90 grados.
- Inyecte la insulina lentamente hasta que el dial de dosis marque '0'. Mantenga presionado el botón de dosis y cuente hasta 5-10 antes de retirar la aguja.
- Deseche la aguja de manera segura en un recipiente de plástico rígido.

Problemas Potenciales y Solución de Problemas

- **Dolor o hematomas:** Rotar los sitios y evitar inyectar en el músculo.
- **Pérdida de insulina después de la inyección:** Mantener la aguja en su lugar durante 5-10 segundos antes de retirarla.

- **La glucosa no mejora:** Verificar dosis, horario y técnica. Comuníquese con su proveedor si los problemas persisten.

Cómo Reconocer y Tratar la Hipoglucemia (Bajo Nivel de Azúcar en Sangre)

Síntomas: Temblores, sudoración, mareos, confusión, hambre, dolor de cabeza, debilidad. Si presenta alguno de estos síntomas, controle su nivel de azúcar en sangre. Si su nivel de azúcar en sangre es inferior a 70, siga la regla del 15.

Tratamiento - La Regla del 15:

1. Consumir 15 gramos de carbohidratos.
2. Esperar 15 minutos y revisar la glucosa en sangre.
3. Si aún está baja (<70 mg/dL), repetir. Continuar hasta que la glucosa sea >90 mg/dL.
4. Una vez normalizada, ingerir un refrigerio equilibrado con proteínas y carbohidratos si la próxima comida es en más de una hora.

Mitos Sobre la Insulina

Mito: Usar insulina significa que mi diabetes es grave.

Verdad: Necesitar insulina no es un fracaso, sino un ajuste necesario para mantener a usted y a su bebé saludables. Las hormonas del embarazo pueden dificultar el control del azúcar en sangre, incluso con una buena alimentación.

Mito: La insulina dañará a mi bebé.

Verdad: La insulina no atraviesa la placenta y es la forma más segura de reducir el azúcar en sangre durante el embarazo.

Mito: Una vez que empiece a usar insulina, siempre la necesitaré.

Verdad: Muchas mujeres dejan de usar insulina después del parto cuando su glucosa en sangre vuelve a la normalidad.

Mito: La insulina causa un aumento excesivo de peso.

Verdad: Una dosis adecuada de insulina ayuda a controlar el azúcar sin causar un aumento innecesario de peso. El aumento de peso en el embarazo es normal y saludable.